

Etiology of Mental Disorders

علل و عوامل موثر بر بیماری های روانی

Nima Sadeghzadeh

MSc in Psychiatric Nursing

- **اتیولوژی**
- **علل اختلالات روانی**
- **موانع مشکل ساز در دستیابی به علت اصلی و دقیق بیماری های روانی**

1. علایم مختلف
2. رفتار غیر قابل پیش بینی
3. اندیشه های متفاوت
4. جستجوی گذشته
5. مسایل اخلاقی
6. تفاوتهای فرهنگی
7. بررسی طولانی مدت
8. رابطه همبستگی
9. رفتار هنجار و نابهنجار



فرضیه های قدیمی مطرح شده

1. فرضیه تن زادی (Somatogenic Theory)

- اولین بار توسط بقراط مطرح شد
- نقص جسمی را باعث اختلالات روانی می دانستند

2. فرضیه روان زادی (Psychogenic Theory))

- اختلالات روانی منشا روان شناختی دارند

طبقه بندی عوامل مؤثر بر بیماری های روانی

نحوه تأثیر عوامل

نوع عامل

طبقه بندی بر اساس نحوه تأثیر عوامل

1. **عوامل زمینه ساز Predisposing Factor**
2. **عوامل آشکارساز Precipitating Factor**
3. **عوامل دوام دهنده Perpetuating Factor**

1. عوامل زمینه ساز

- از آغاز زندگی فرد
- فاصله زیاد با بروز اختلال
- ادامه در طول زندگی
- تا حدودی قابل مداخله
- فرد را آماد پذیرش بیماری

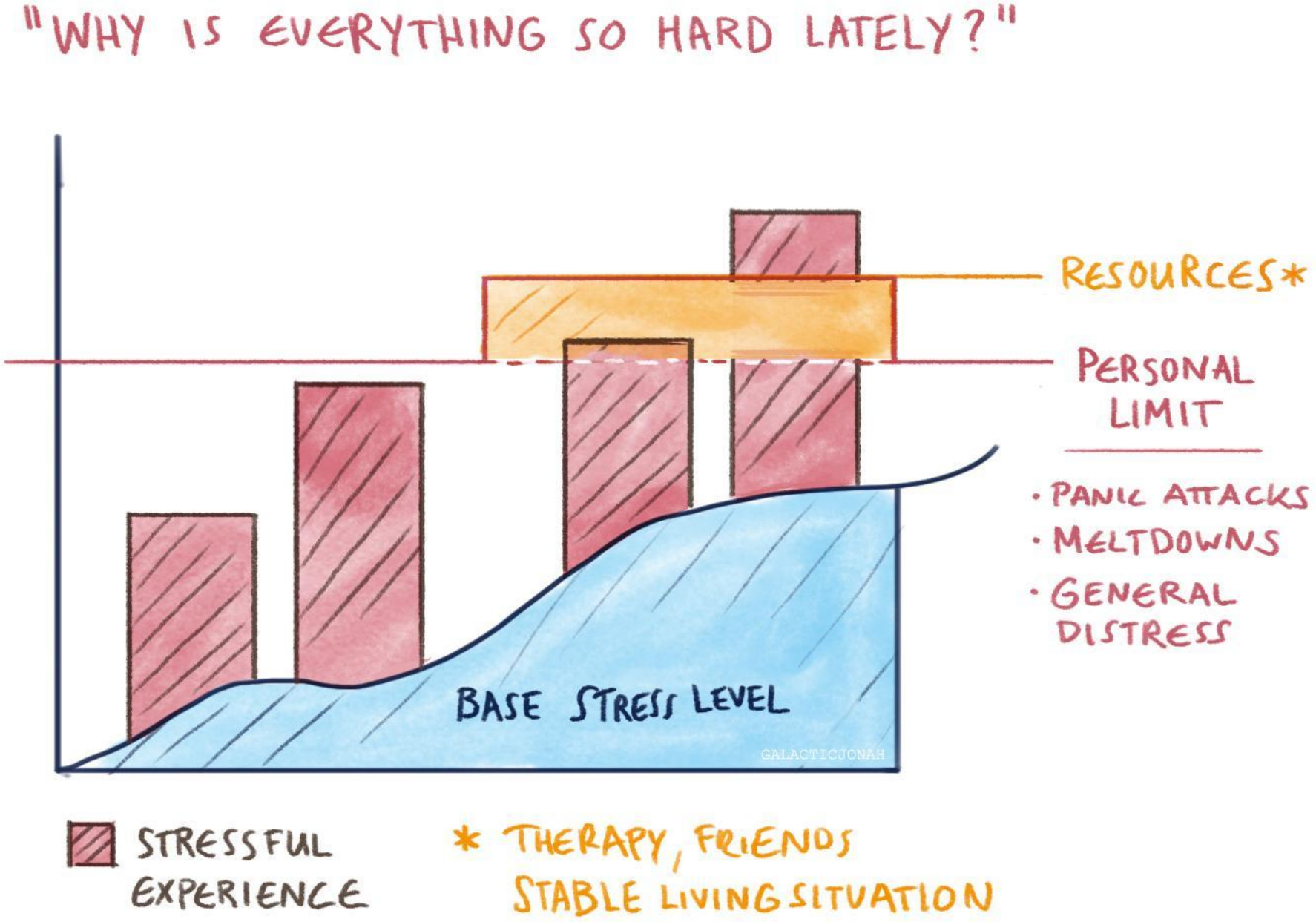
2. عوامل آشکارساز

- فاصله نسبتا کم با بروز علایم
- غیر قابل مداخله
- فیزیکی (بیماری های مغزی، تومور، عفونت، تروما، دارو) یا روانی اجتماعی (مشکلات شخصی، ازدواج، بچه دار شدن، مهاجرت، طلاق، یائسگی)

3. عوامل دوام دهنده

- تداوم بعد از بروز علایم
- قابل مداخله درمانی
- باورهای غلط فرهنگی، اجتماعی یا عوامل اقتصادی، عوامل خانوادگی

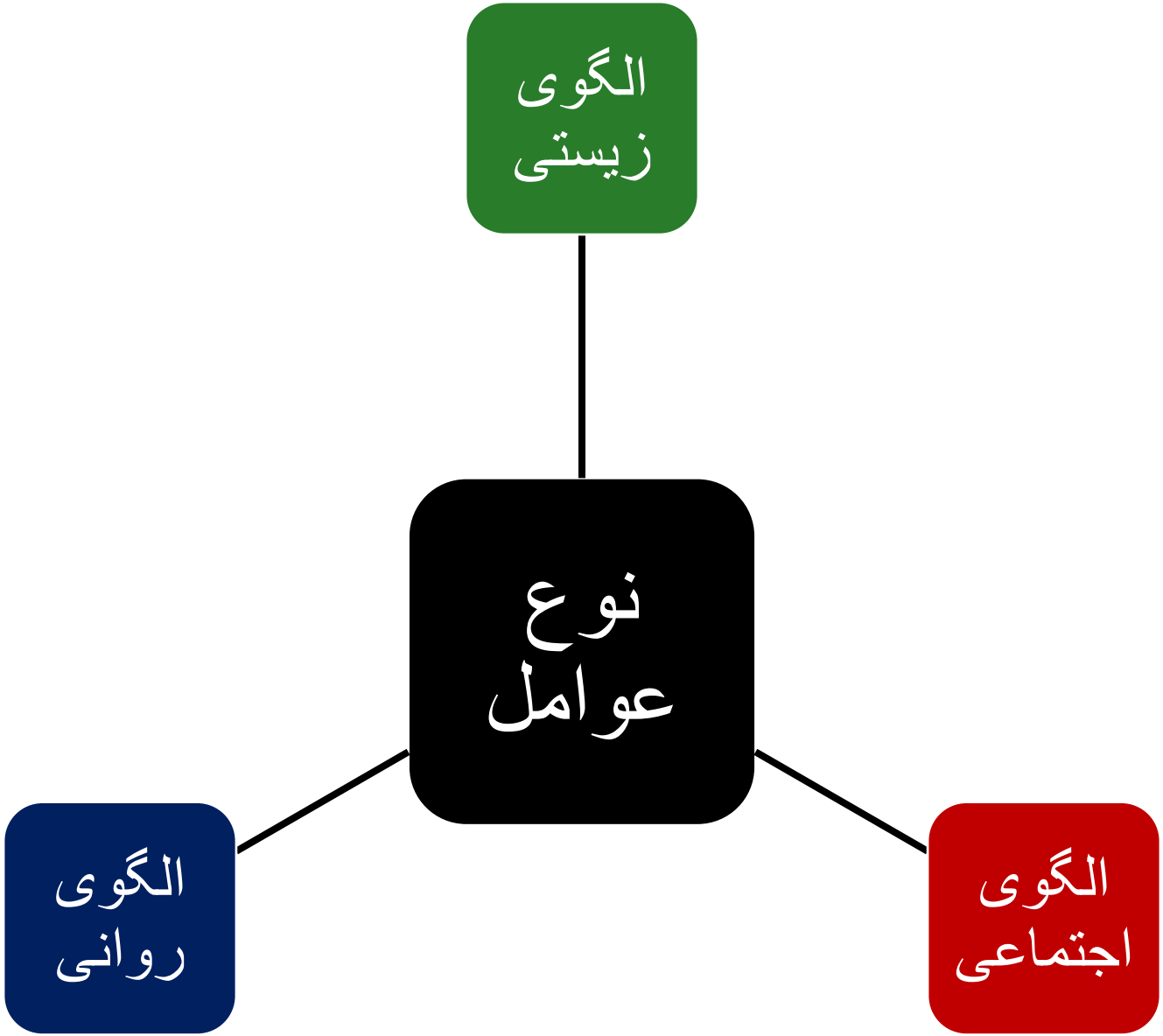
Diathesis – stress model



طبقه بندی عوامل مؤثر بر بیماری های روانی

نحوه تأثیر عوامل

نوع عامل


الگوی زیستی
نوع عوامل
الگوی روانی
الگوی اجتماعی

الگوی زیستی

1. **زمینه ژنتیکی**
2. **بیولوژیکی**

- **اختلال در کارکرد سیستم عصبی**
- **اختلالات سیستم آندوکرینی**
- **اختلالات سیستم ایمنی**
- **اختلال در ریتم های زیست شناختی**

ژنتیک

به 3 طریق: خانواده های، دو قلوها، فرزند خوانده ها

خانواده:

- درجه 1>2>3
- یک والد دو قطبی= 25% فرزند
- هر دو والد دو قطبی= 50-75% فرزند
- گاتزمن (1978): اسکیزوفرنی در یک والد= 12-13%؛ هردو والد=36-37%؛ درجه 2 و 3= 2-3%
- اسکیزوفرنی در یک والد = 10 برابر کردن شانس ابتلا به اسکیزوفرنی در فرزند نسبت به جمعیت عادی

ژنتیک

به 3 طریق: خانواده های، دو قلوها، فرزند خانواده ها

دو قلوها:

- یک تخمکی> سایر فرزندان / ابتلای همزمان اسکیزوفرنی 50% و خلقی 33-90% (محیط و آشکار کننده)
- دو تخمکی: Price 1998 افسردگی در یک تخمکی 68% دو تخمکی 67% و در نک تخمکی 23%

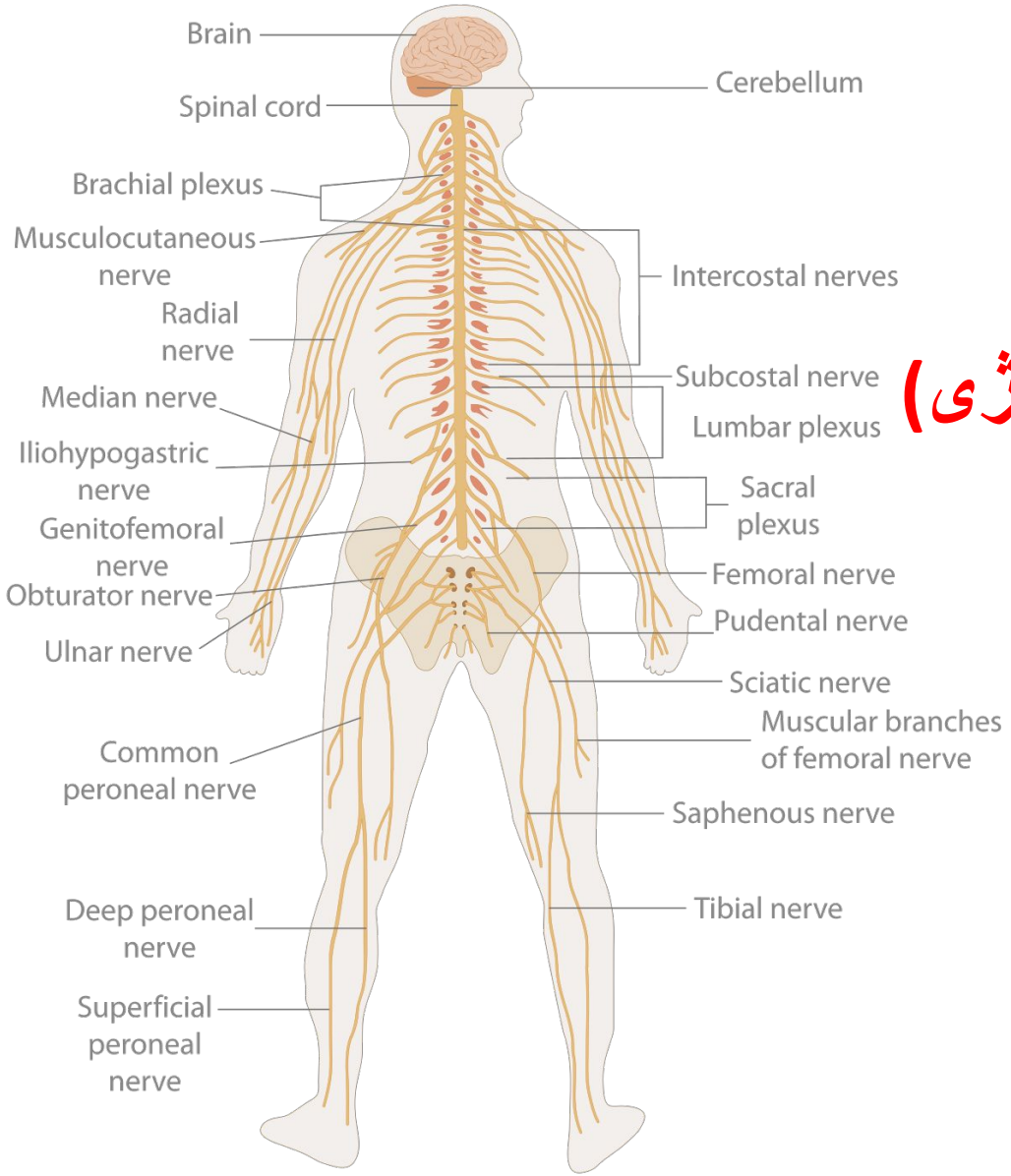
- **فرزند خوانده ها**

الگوی زیستی

1. **زمینه ژنتیکی**
2. **بیولوژیکی**

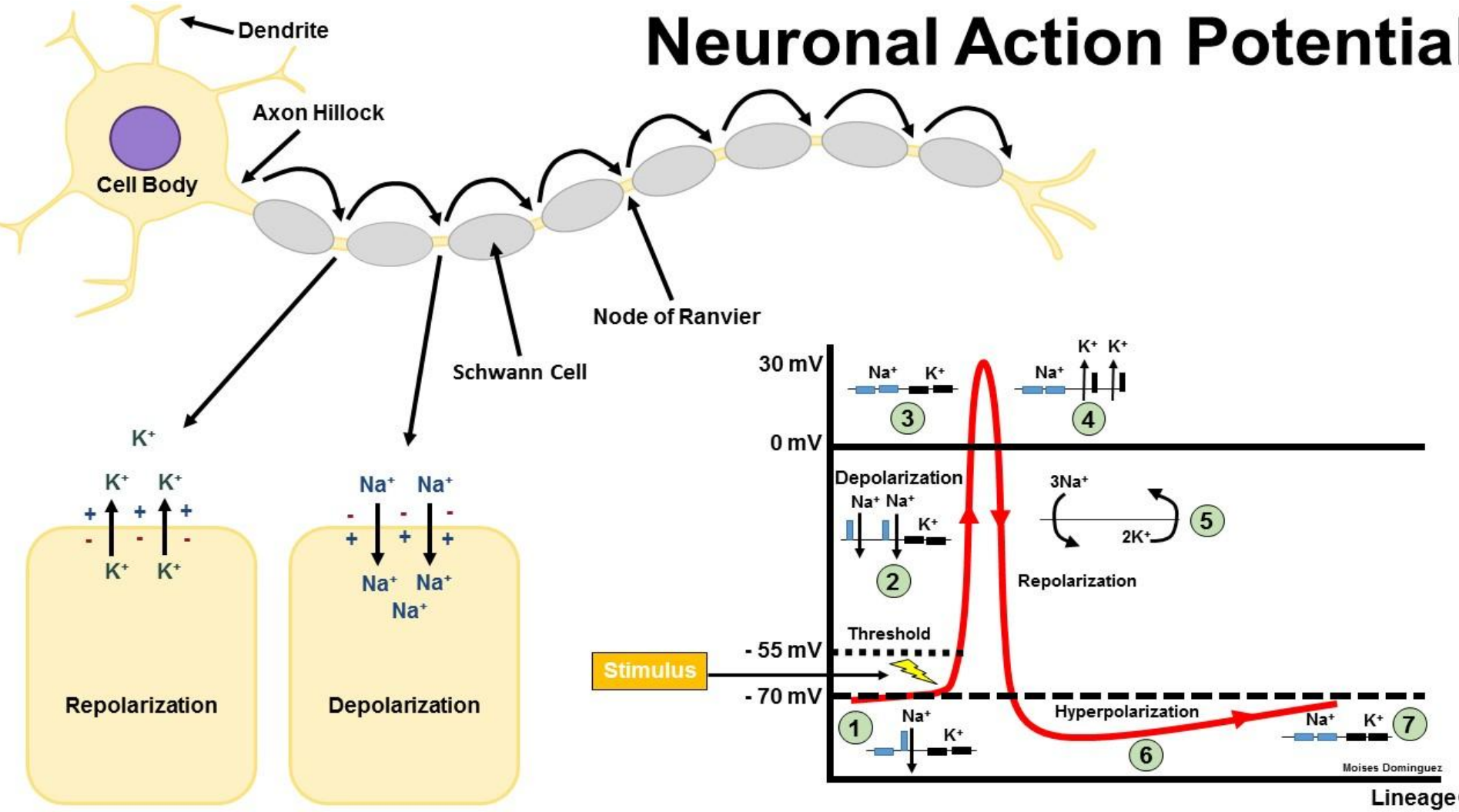
- **اختلال در کارکرد سیستم عصبی**
- **اختلالات سیستم آندوکرینی**
- **اختلالات سیستم ایمنی**
- **اختلال در ریتم های زیست شناختی**

اختلال در کارکرد سیستم عصبی



1. فیزیولوژیک (نوروفیزیولوژی)
2. نوروشیمیایی
3. ناهنجاری های آناتومیک

- فیزیولوژیک (نوروفیزیولوژی)
  - اختلال در مجاری یونی
  - از طریق داروهای ضد صرع (دو قطبی)



- **نوروشیمیایی**
  - نوروترنسمیتر یا گیرنده
  - از طریق تاثیر دارو روی کنترل بیماری های روان
  - افزایش سرتونین: مانیا
  - کاهش گابا: افسردگی
  - افزایش گیرنده های دوپامینی: اسکیزوفرنی
  - دوپامین: تاثیر داورهای آنتی سایکوتیک (مهار کننده گیرنده دوپامینی)
    - آمفتامین: افزایش فعالیت گیرنده های دوپامین و ایجاد علایم سایکوز
    - افزایش در مانیا و کاهش در افسردگی
  - نور اپی نفرین و < اپی نفرین: TCA/MAOi/بوپروپیون باعث جلوگیری از باز جذب مجدد= کاهش علایم افسردگی
  - سرتونین: SSRi
    - مصرف تریپتوفان: افزایش سرتونین و بهبود علایم افسردگی

ناقل های عصبی Neurotransmitter

	گیرنده	اثرات	افزایش	کاهش
دوپامین	D1 تا D5	تنظیم حرکات ، خلق ، یادگیری ، خواب ، توجه	اسکیزوفرنی – مانیا	افسردگی - پارکینسون
سروتونین	5-HT1 تا 5-HT7	تنظیم خواب ، اشتها ، خلق	مانیا	افسردگی – بی خوابی – پرخاشگری – اضطراب – اختلال وسواسی جبری
اپی نفرین و نوراپی نفرین	α1 α2 β1 β2	آغازگر واکنش جنگ یا گریز	مانیا – اضطراب – افسردگی	افسردگی
گاما آمینوبوتریک اسید (گابا)	GABAa تا GABAc	مشخص نشده است	کاهش اضطراب	اختلالات اضطرابی
استیل کولین	موسکارینی و نیکوتینی	تاثیر در یادگیری و حافظه، تنظیم کننده خلق، تحریک پاراسمپاتیک	افسردگی	آلزایمر، پارکینسون، هانتینگتون
		آگاه، پاسخ های ضد		

الگوی زیستی

فاکتورهای بیولوژیکی

2. اختلال در کارکرد سیستم عصبی

3.ناهنجاریهای ساختمانی سیستم عصبی

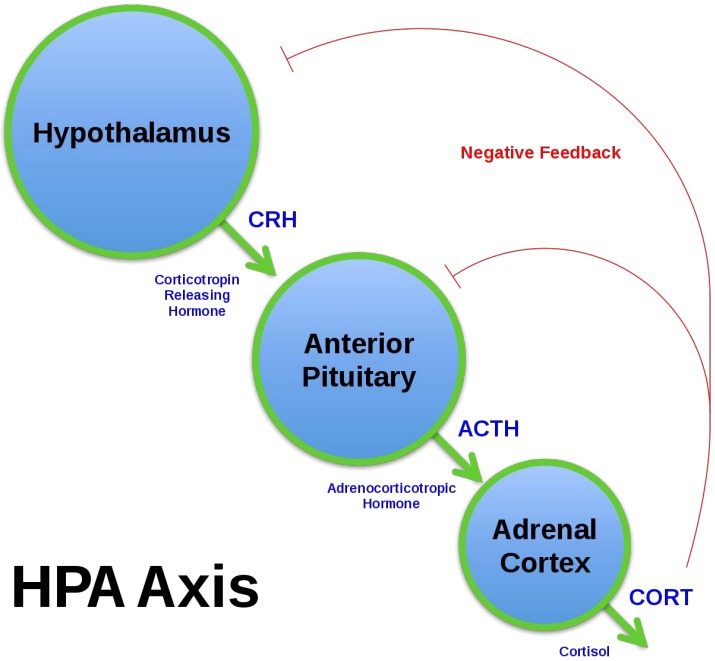
- **نواقص مادرزادی**
- **صدمات زایمانی**
- **ضربه شدید به سر**
- **بیماریهای عصبی**
- **اتساع بطن های مغزی و یا آتروفی قشر مخ در بیماران اسکیزوفرن و اختلالات خلقی**
- **کاهش وزن ماده خاکستری مغز در اسکیزوفرن**

...[illegible]			
occipital[illegible]	Temporal[illegible]	Frontal[illegible]	parietal[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	
		[illegible]	
		[illegible]	
		[illegible]	

الگوی زیستی

1. **زمینه ژنتیکی**
2. **بیولوژیکی**

- **اختلال در کارکرد سیستم عصبی**
- **اختلالات سیستم آندوکرینی**
- **اختلالات سیستم ایمنی**
- **اختلال در ریتم های زیست شناختی**



اختلال در سیستم اندوکرینی

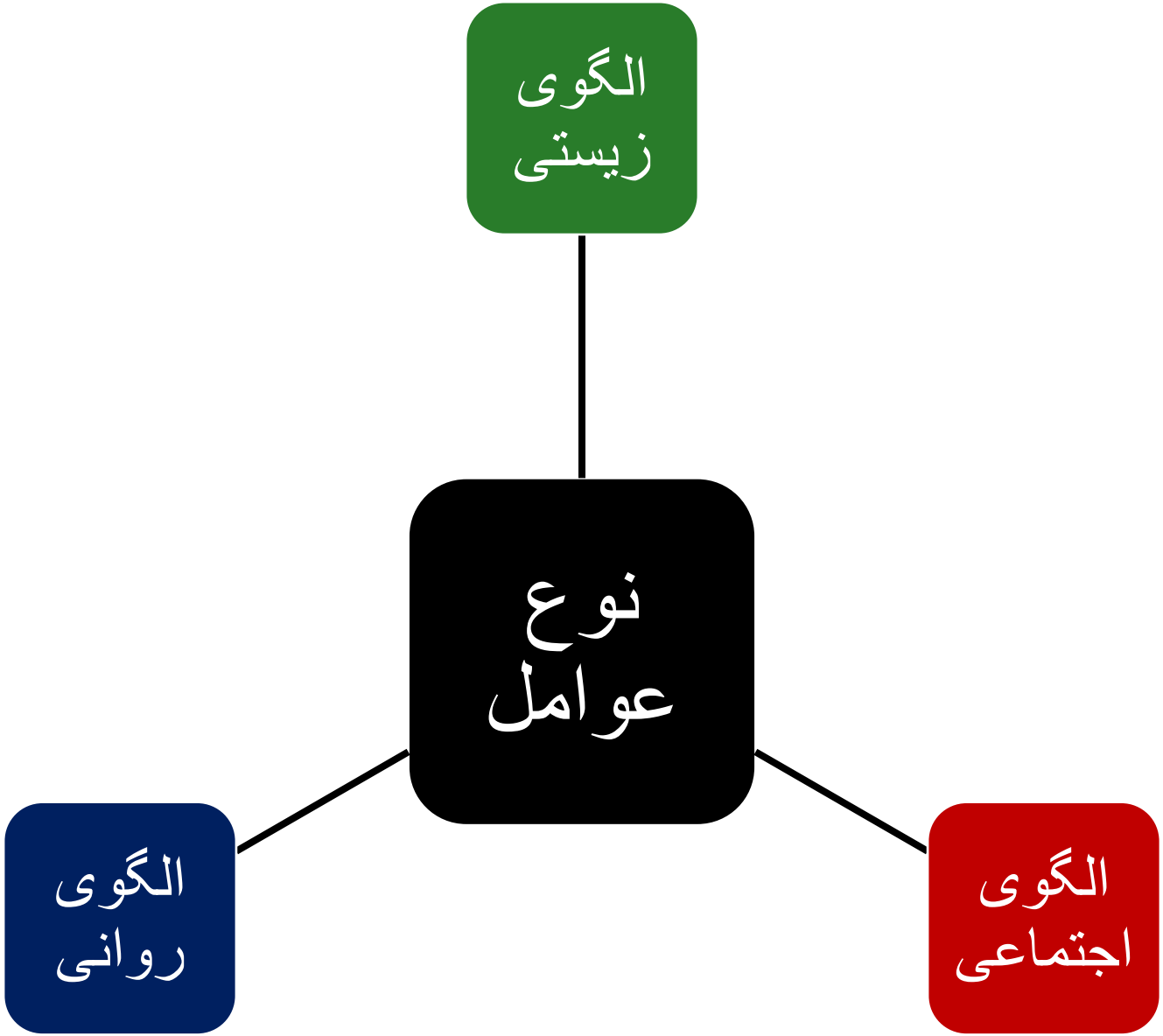
- هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق کلیه
- در افسرده ها=سطح کورتیزول بالا
  - سندرم کوشینگ:50% افسردگی و 10% سایکوتیک و افکار خودکشی
- کاهش هورمون های تیروئید: افسردگی و اضطراب
- افزایش هورمون های تیروئید: تحریک پذیری، بی خوابی، اضطراب، بی ثباتی هیجانی، مانیا، پارانوئید

اختلال در سیستم ایمنی

- مستقیم: عفونت و کاهش لنفوسیت های T: افسردگی
  - عفونت ویروسی دوران جنینی، زمان تولد یا اوایل زندگی: اسکیزوفرنی
- غیر مستقیم: MS و MI

اختلال در ریتم های زیست شناختی

- تحت تاثیر عوامل بیرونی (دوره روشنایی و تاریکی، الگوی غذا) و درونی (هسته های سوپرا کیاسماتیک هیپوتالاموس)
- خوب و بیداری، سطح هورمونی، حرارت بدن، دوره قائدگی
- افسردگی: بیاری اول صبح، کاهش خواب REM، آشفتگی هورمونی


الگوی زیستی
نوع عوامل
الگوی روانی
الگوی اجتماعی

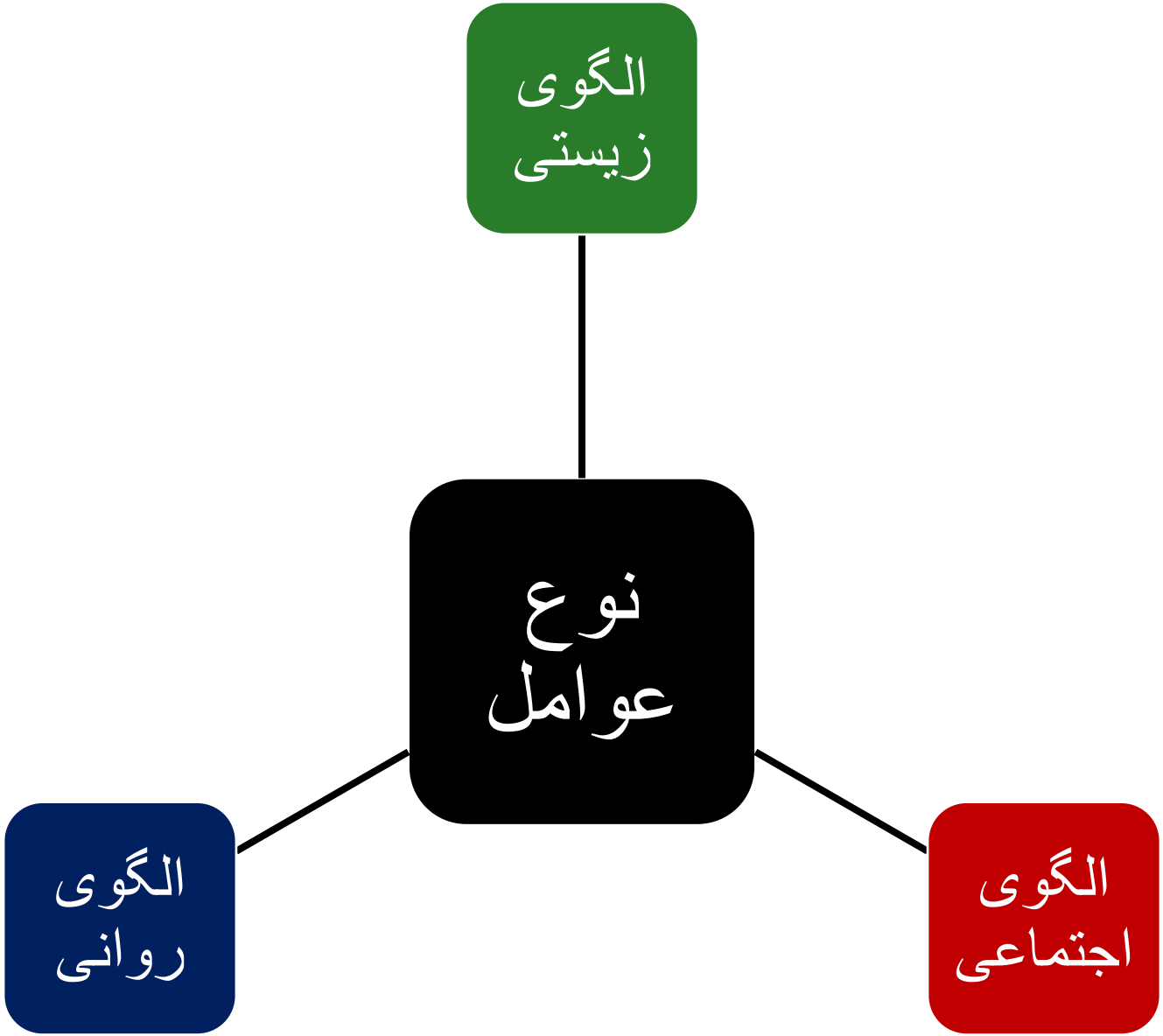
الگوی اجتماعی (عوامل اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی)

- طبقه اجتماعی
  - بر اساس قدرت اقتصادی/ اعتبار اجتماعی/ هویت سیاسی و الگوهای ارتباطی/ سبک زندگی/ تفریحات/ فرم شخصیت
  - سببیت اجتماعی (Social Causation)
  - انتخاب اجتماعی (Social Selection)
- شبکه اجتماعی و حمایت اجتماعی
- رویداد های استرس زای اجتماعی
- عوامل جمعیت شناختی (دموگرافیک)
- فرهنگ

فرهنگ

- سبک، عادات، سلیقه ها، اعتقادات، ارزش ها، شیوه تربیت فرزند، انتظارات
- مثل شک و تردید
- (نقش های متفاوت) سندرم وابسته به فرهنگ
- فقط خود فرهنگ نیست بلکه تغییر فرهنگ (شوک فرهنگی Cultural Shock)




الگوی زیستی
نوع عوامل
الگوی روانی
الگوی اجتماعی

الگوی روانی

- **الگو های فرزند پروری آسیب زا**
  - اختلال در ایفای نقش (تمایل زوجی و گسستگی زوجی)
  - اختلال در روابط (پیام های دوگانه، نبود عاطفه و روابط عاطفی صحیح)
- **رشد و شکل گیری شخصیت نا بهنجار**
  - حضور هردو والد برای رشد بهنجار
- **تجارب ناگوار دوران کودکی**
- **ناکامی ها و تعارضات حل نشده**

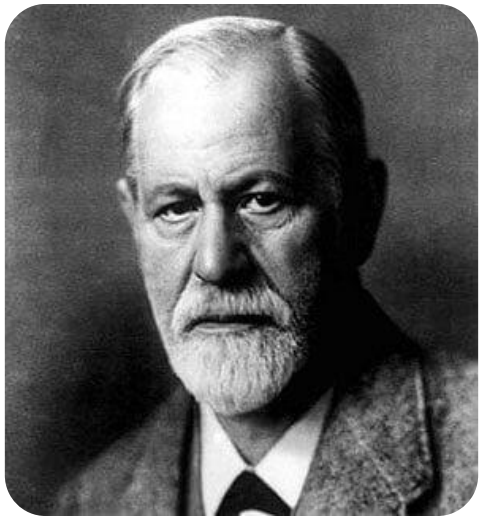
رویکرد های روان شناختی در اتیولوژی اختلالات روانی

1. رویکردهای روان کاوی
   - زیگموند فروید
   - آلفرد آدلر
   - اریک اریکسون
   - کارن هورنای
   - هری استاک سالیوان
2. رویکردهای انسان گرایی
3. رویکردهای رفتار گرایی
4. رویکردهای شناختی

1. رویکردهای روان کاوی

زیگموند فروید

- نظریه روان پویایی
- شخصیت و اختلالات روانی حاصل تعامل پویا بین« نهاد Id» «من Ego»و« من برترsuper ego »
- تعادل روانی فرد به میزان توانایی Ego در برابر فشارهایی که از سوی Id، Super Ego و واقعیتهای بیرونی به آن وارد می شود بستگی دارد.



سن	مرحله	عبور موفقیت‌آمیز	تثبیت
تولد تا ۱۲ الی ۱۸ ماهگی	دهانی (مکیدن، گازگرفتن)	از شیر گرفتن، توانایی اعتماد	شخصیت وابسته دهانی، خوش‌بینی، از خودراضی، پرتوقع، سلطه‌جو، عادات دهانی مانند پرخوری، ناخن جویدن، استعمال سیگار، جویدن آدامس، پرحرفی و فحاشی، سوءمصرف الکل بدبین، بی‌اعتماد، خودکم‌بین، وابسته
۱۲ الی ۱۸ ماهگی تا ۳ سالگی	مقعدی (دفع و نگه‌داری مدفوع)	آموزش آداب توالت رفتن، خودکنترلی، مسؤولیت، خودمختاری	شخصیت مقعدی، شخصیت وسواسی (نظم و ترتیب افراطی، سرسختی، خسّت و صرفه‌جویی) بی‌نظمی، شلختگی و بی بند و باری
۳ تا ۵ سالگی	آلتی (عقده ادیپ و الکترا)	همانندسازی با والد همجنس و تشکیل هویت جنسی، رشد من‌برتر	جاه طلبی، مشکل با صاحبان قدرت، احساس اخلاقی ضعیف، نارضایتی از جنسیت خود
۵ تا ۱۱ سالگی	نهفتگی	کسب مهارت‌های اجتماعی	عدم رشد مهارت‌های اجتماعی، احساس بی‌کفایتی، سردرگمی در مورد انتظارات
نوجوانی	ژنیتالی	کنترل غرایز زیستی، عشق و شایستگی در زمینه‌های کاری	سردرگمی و آشفتگی در مورد تغییرات زیست‌شناختی و غرایز، رفتارهای مرضی

1. رویکردهای روان کاوی

آلفرد آدلر

- رفتارهای نادرست والدین با کودک (سلطه گری- بی توجهی – نازپروری – لوس کردن و در نتیجه احساس مبالغه آمیز مهم بودن و مشکل در سازگاری با همسالان و روابط اجتماعی)
- سلطه گری والدین و طغیان گری کودک
- عیب جویی والدین منجر به سبک زندگی وسواسی در کودک



1. رویکردهای روان کاوی

اریک اریکسون

1. **0-1 سال: اعتماد بنیادی / بی اعتمادی**
2. **3-1 سال: خودمختاری / شرم و تردید**
3. **5-3 سال: ابتکار /احساس گناه**
4. **11-6 سال: سازندگی /حقارت**
5. **12-11 سال: هویت/ سردرگمی نقش**
6. **40-21 سال: صمیمیت/ انزوا**
7. **65-40 سال: مولد / بی حاصلی**
8. **بالای 65 سال: احساس کمال/ناامیدی**

مراحل رشد	اختلالات مربوطه
اعتماد در مقابل عدم اعتماد	اختلالات سایکوتیک، اعتیاد، افسردگی، پارانوئید، اسکیزوئید
خودمختاری در مقابل شرم و تردید	اختلالات شخصیت وسواسی - جبری، تکانش‌گری
ابتکار در مقابل احساس گناه	اختلالات تبدیلی، پانیک، روان - تنی
سازندگی در مقابل احساس حقارت	احساس بی‌کفایتی، تنبلی
هویت در مقابل سردرگمی نقش	اختلالات سلوک، هویت جنسی، شخصیت مرزی
صمیمیّت در مقابل انزوا	اختلالات شخصیت اسکیزوئید، دوری‌گزین
مولّد بودن در مقابل بی‌حاصلی	بحران میان‌سالی، بیماری مزمن زودرس
کمال در مقابل یأس و ناامیدی	احساس ناامیدی، افسردگی

1. رویکردهای روان کاوی

کارن هورنای

- ✔ صفات شخصیتی ماحصل تعامل بین انسان و محیط
- ✔ اساس اختلالات روانی، اضطراب بنیادی
- ✔ اضطراب بنیادی: احساس بیچاریگی، ناتوانی و عجز کودک در برابر محیط بسیار خطرناک
- ✔ علت اضطراب بنیادی: فقدان شرایط صمیمانه و محبت آمیز در خانواده
- ✔ بیمار روانی تلاش بسیار زیاد و افراطی و نامتعادل برای برطرف کردن اضطراب بنیادی



1. رویکردهای روان کاوی

هری استاک سالیوان

- تاکید بر نقش روابط بین فردی در تشکیل خودپنداری
- خودپنداری منفی در اثر ارتباط نامناسب با دیگران منجر به اختلالات روانی



2. رویکردهای انسان گرایی

- **مازلو: عدم ارضاء به موقع نیازها ، فرد را در معرض ابتلا به اختلالات روانی قرار می دهد**

- **راجرز: اگر والدین برای محبت و توجه به کودک شرط بگذارند،در کودک خوپنداره ناسالم رشد می کند**

3. رویکرد های رفتار گرایی

- **اختلالات روانی از تعارضات درونی منشا نمی گیرند**
- **مانند رفتارهای درست از یادگیری ناشی می شوند**
- **اختلالات روانی نتیجه آموخته ها و عادت های نادرست است**
- **برای درمان اختلالات روانی ، رفتار درمانی را پیشنهاد می کنند**

4. رویکردهای شناختی

- بر خلاف رفتار گرایی ، علت اختلالات روانی ،رویدادهای ذهنی است
- مثلا علت افسردگی یک فرد ، نحوه تفکر او در مورد خود و دنیاست
- ارائه مدل تریاد شناختی افسردگی توسط آئورن بک

-برداشت منفی از خود

-تعبیر منفی تجربه ها

-انتظار منفی از آینده